猫咪腹泻·深度科普与解决大全（v4 充实版）

基于权威兽医信源的系统指南 + 多多（6月龄·公·狸花猫）专属排查、调整、养护与行为方案

版本 v4 | 生成日期 2026-10-16 | 含修复后 SVG 图表 + Part E 问答宝库（30+ 高频问答） | v4 充实：头脑风暴问答 FAQ、更多速查表与误区辟谣、就医检测与产品测评

阅读须知（必读）：本文为面向养猫人的**科普与居家管理参考**，内容来自公开权威兽医资料并标注来源，**不能替代执业兽医的诊断与治疗**。猫咪病情多变，出现血便、呕吐、沉郁、脱水、体重下降等警示信号，或腹泻持续不缓解，请及时就医。文中"京东京造"等具体商品仅为结合多多个案的客观评估，**不构成推荐或背书**。

目录

Part A 知识大科普

A1 什么是腹泻（含粪便评分图）

A2 四大病理机制（图解）

A3 急性/慢性 + 小肠/大肠鉴别

A4 常见病因谱

A5 年龄分层

A6 急诊红线

Part B 解决方法大全

B1 标准化排查路径（决策树）

B2 饮食调整：原料与理论 + 按体重算量

B3 水分管理

B4 过渡换粮法（含"只有新粮"情形）

B5 益生菌 / 益生元

B6 常用药物机理与红线

B7 居家护理与记录表

B7.5 别的猫吃没事、他一吃就拉?

B8 人猫可共享的恢复餐（5 个一锅菜谱）

B9 可冷冻预制菜谱 5 个（加热即食）

B10 京东京造 0谷物6肉8果蔬 猫粮评估

Part C 多多专属方案

C1 个案时间线复盘

C2 研判（事实/推断/建议）

C3 14天调整计划

C4 一页式快速排查卡

C5 怎么喂：定时 vs 自由 + 决策树

Part D 养护与行为

D1 如何判断猫咪吃饱了

D2 按体重计算每日猫粮量

D3 定时定量 vs 自助采食

D4 毛色变黄：营养不够还是其他原因

D5 常见猫行为状态判断

D6 如何训练猫咪

D7 撸猫舒服却转头抱手咬：原因与改善

Part E 常见问答 FAQ（头脑风暴宝库）

E1 诊断决策类问答

E2 居家处理类问答

E3 喂养营养类问答

E4 误区辟谣类问答

E5 特殊场景类问答

E6 就医与检测类问答

E7 产品与测评类问答

参考文献与来源

Part A • 知识大科普

A1 什么是腹泻

定义：腹泻是粪便性状变稀、排便次数或总量多于正常，本质是"肠内容物通过过快 + 水分/电解质吸收减少"。VCA Animal Hospitals 明确指出：**腹泻本身不是疾病，而是众多疾病的共同症状**；即使由轻症引起，若不及时处理也可能因脱水等变得严

重（VCA Animal Hospitals, "Diarrhea in Cats"）。

健康猫的粪便应为**成形、分节、捡起不散**。判断是否腹泻，看三件事：**形态（软/糊/水）、频率（是否明显增多）、是否带血/黏液**。若频繁液状或半液状粪便**持续超过 2 天**，应咨询兽医（VCA）。

图1 • 粪便性状评分谱（1–7 级，猫用改编版）

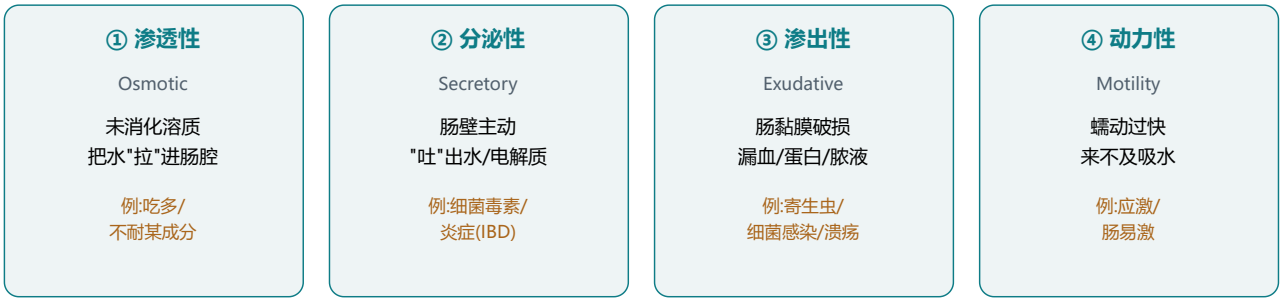


猫的理想粪便约在 2–3 级；4 级起属"软便"，5–7 级属腹泻。居家每天铲砂看一眼即可自评。

> 评分方法（居家可用）：每天记录便便落在哪一级、次数、颜色、是否带血/黏液。连续 3 天 ≥5 级即算"腹泻在活动"，应进入 Part B 排查流程。

A2 腹泻的四大病理机制（为什么"拉稀"）

无论病因是什么，腹泻最终都通过以下四类机制之一（或组合）发生（catmd.ca, "Diarrhea"）：



真实病例常为多种机制叠加；偷吃变质虾头即"渗透+分泌+渗出"三联击。

> 理论要点：**渗透性腹泻在禁食/减量后会明显减轻**（因为少了"未消化溶质"）；**分泌性/渗出性腹泻禁食也难停**，往往提示感染或炎症，需要就医。这条规律是居家判断"能不能先观察"的关键。

A3 急性/慢性之分 + 小肠/大肠鉴别

急慢性：腹泻 **≤2–3 周**多为急性（食物、寄生虫、感染、应激）；**持续 >3 周，或一个月内间歇性反复**即归为慢性（Expert Cat Care；SpectrumCare, "Chronic Diarrhea in Cats"）。慢性不等于严重，但意味着需要系统排查，而非仅靠禁食。

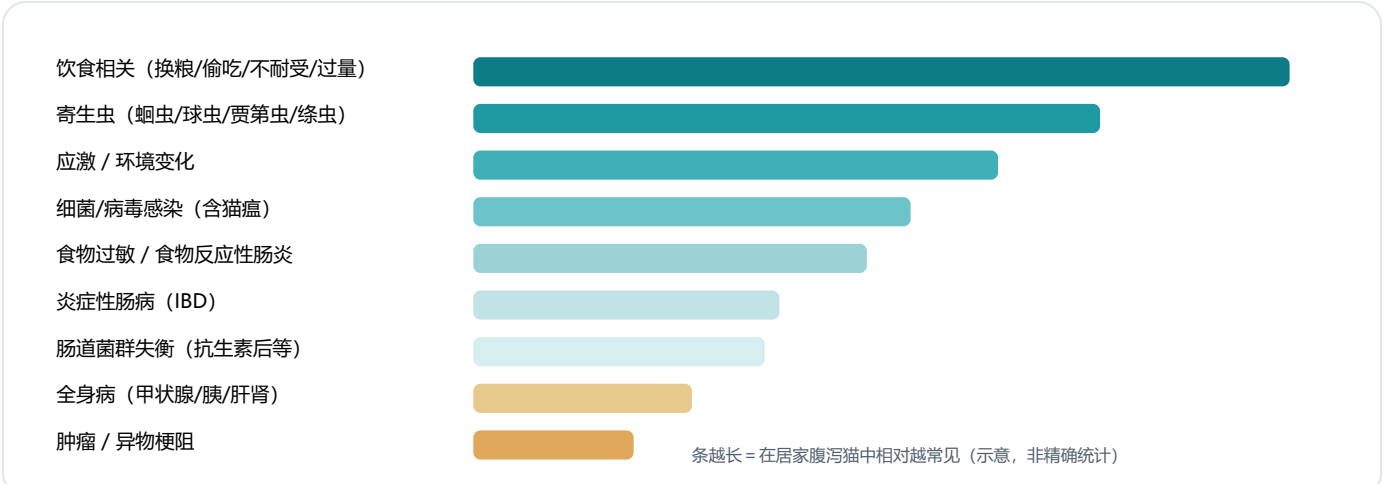
定位（小肠 vs 大肠）是兽医缩小病因范围的第一步。看大便"长什么样"就能初判（Small Animal Internal Medicine, 教科书 Table 11-1；Expert Cat Care）：

特征	小肠性腹泻（Small bowel）	大肠性腹泻（Large bowel / 结肠）
排便量	正常或增多	减少（每次少量）
排便频率	正常或轻度增多	明显增多（频繁跑砂盆）
黏液	通常无	常有（果冻状）
血	若有→黑便/柏油样（消化过）	常有鲜红血（hematochezia）
里急后重/努责	无	常有
呕吐	可能出现	可能出现
体重下降	**常见**	少见
典型病因	食物不耐受、IBD、寄生虫(蛔虫/绦虫)、胰/甲状腺/肝肾等全身病	结肠炎、应激、球虫/贾第虫、部分食物过敏、直肠异物

> 多多个案提示：**间歇性软便、精神食欲好、无血无黏液无消瘦**——更接近"轻度、以饮食/菌群相关为主"的模式，倾向于大肠性或轻度小肠性，暂未指向严重全身病。但仍需按慢性流程管理（见 Part C）。

A4 常见病因谱（相对常见度，示意排名）

下图按"在居家猫中出现的大致相对频率"排序，**仅供优先级参考，非流行病学精确比例。**注意：小猫（如多多）感染性/饮食性占比更高。



A5 年龄分层：幼猫 / 青年猫 / 老年猫

年龄段	更常见病因	特别提醒
幼猫（<6月，如多多）	寄生虫、感染、换粮/偷吃、先天性消化弱、低血糖风险	免疫系统未成熟；**禁食耐受差，小猫别长时间断食**；脱水更快
青年/中年（1–7岁）	食物过敏（食物反应性肠病）、IBD、应激、异物	慢性病开始显现，需做食物排查试验
老年（>7岁）	慢性肾病、甲亢、肠癌、慢性胰炎、EPI	"吃多还瘦+一直拉"要查甲功/肾/胰

A6 急诊红线：何时必须就医

出现以下任一，不要在家硬扛，尽快就医：

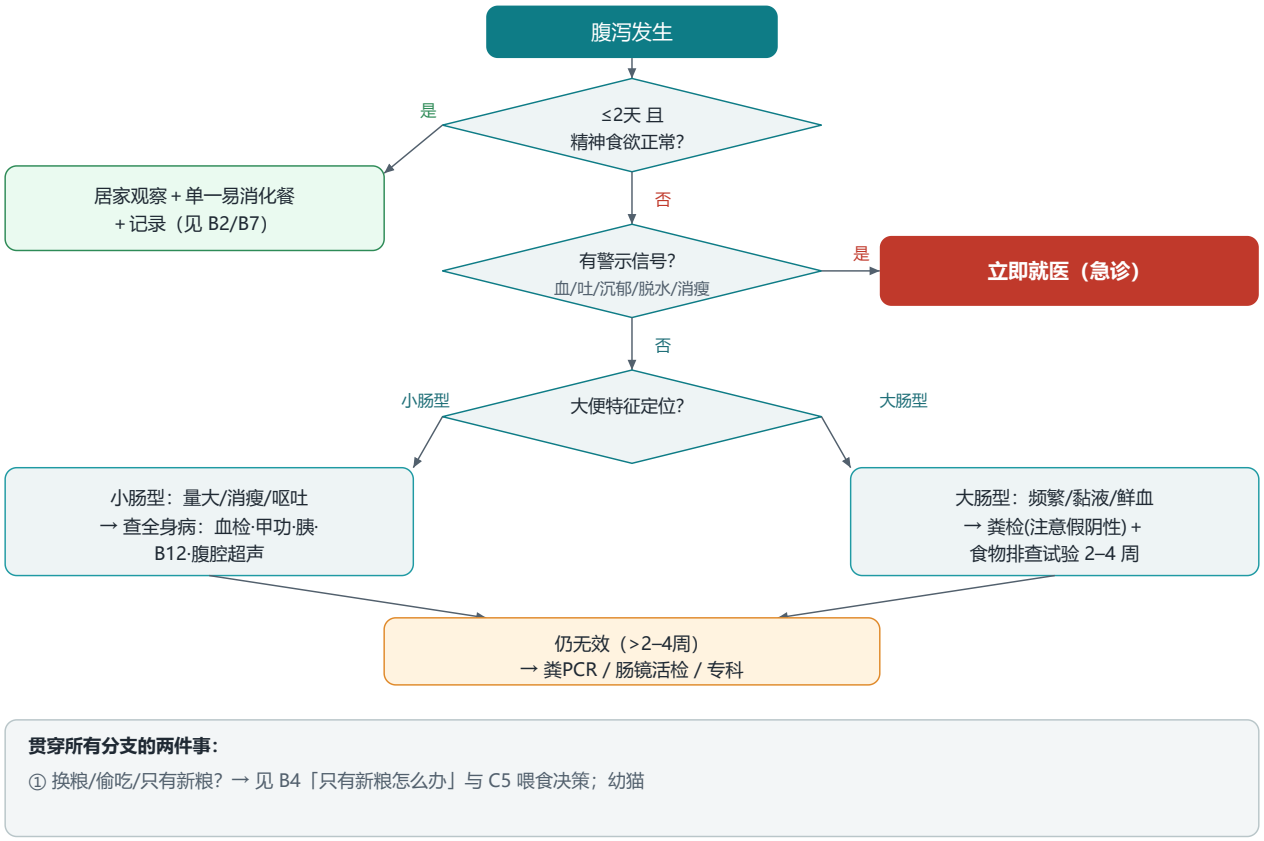
- **血便**（鲜红或黑柏油样）或大量黏液
- **呕吐**（尤其频繁、带黄绿胆汁、带血）
- **精神沉郁**：嗜睡、躲藏、反应迟钝、不爱动
- **脱水**：提起颈后皮肤回弹慢、牙龈干、眼窝凹陷
- **体重下降 / 消瘦**、食欲明显减退或拒食
- 腹泻 **持续 >2 天无改善**，或 **反复发作超 3 周**
- 疑似**吃了异物 / 有毒物**（葱蒜、葡萄、巧克力、药）
- **小猫（<6月）腹泻伴精神差**——风险高于成年猫

来源：VCA Animal Hospitals；SpectrumCare；猫后苑（HK）。

Part B • 解决方法大全

B1 标准化排查路径（决策树）

把"看到腹泻→该做什么"固化成一条可执行的链路。下图覆盖**居家观察 / 急诊 / 小肠•大肠定位 / 寄生虫 / 食物试验 / 进一步检查 / 换粮偷吃情形**。若图片显示异常，请用浏览器/ima客户端查看原文。



别长时间断食。 ② 全程记录便便分级（目标 2–3 级）、饮食、体重；带**当天新鲜粪便**就医以提高检出率。

居家可执行步骤（精神好、无警示信号时）：

1. **记录**：便便分级、次数、颜色、血/黏液、进食量、精神状态（用 B7 表格）。
2. **暂停"可疑新东西"**：停零食、停新粮、停一切人食；回到"已知不拉"的饮食（若老粮已无，按 B4 处理）。
3. **单一易消化餐**：见 B2 居家温和餐；少食多餐（多多尤要）。
4. **补水**：多放水碗/流动水/肉汤（无盐无葱蒜），见 B3。
5. **观察 24–48 小时**：若升级为警示信号→就医；若好转→维持并缓慢过渡。
6. **若 >2 天无改善或反复**：带"当天新鲜粪便样本"就医，进入专业排查（B1 树）。

B2 饮食调整：原料与理论 + 按体重算量（不推品牌，只讲该有什么、为什么、多少）

用户要求：**不推荐具体品牌商品**，只说明主要原料需要什么、理论依据是什么。以下按"原料 → 理论支持 → 给多多多少"展开。

按体重算每日粮量的通用公式（干粮）

第一步：算静息热量 RER

`RER（kcal/日）= 70 × 体重(kg)^0.75`

第二步：乘生长期系数

6 月龄未绝育幼猫：系数约 **1.8–2.0**；已绝育成猫：1.2–1.4；肥胖猫减重：0.8–1.0。

第三步：换算成干粮克数

普通膨化干粮热量约 **3.6–4.0 kcal/g**（以包装标注为准）。

`日粮克数 ≈ 日需热量 ÷ 干粮热量密度`

快速查表（6 月龄幼猫，系数取 1.9）：

体重	RER	日需热量	日粮克数（按 3.8 kcal/g）	4 餐时每餐
2.0 kg	~118 kcal	~224 kcal	~59 g	~15 g
2.5 kg	~139 kcal	~264 kcal	~69 g	~17 g
3.0 kg（默认按多多估算）	~160 kcal	~304 kcal	~80 g	~20 g
3.5 kg	~181 kcal	~344 kcal	~91 g	~23 g

> **怎么用：**先称多多当前体重，按上表找到基础值；若他"吃多就拉"，从**该体重范围的下限**开始，分 4 餐喂，观察便便 3–5 天。稳定在 2–3 级后，再每周加 3–5g until 达到中位数。不要死守表格，**便便分级是最终裁判。**

原料（日常可购）	理论支持	给多多的量（6 月/约 3kg）
鸡胸肉（超市/菜场，蒸熟，去皮去脂）	高消化率**动物蛋白**、低抗原性、低脂。未消化蛋白进入结肠被发酵→产气+渗透压↑→稀便；易消化的优质蛋白减少"漏网溶质"。腹泻期建议"高消化蛋白+低脂肪"（Radiokop Vet）。	作主食基底，按重量占餐量主体；与南瓜/少量碳水搭配。熟肉湿重每餐 30–50g（分 4 餐）。
南瓜（菜场，蒸熟打成泥，**无任何添加**；贝贝南瓜亦可）	含**可溶性+不可溶性纤维**。可溶性纤维在肠腔吸水成凝胶→固化稀便、减慢通过速度；发酵产**短链脂肪酸(SCFAs)**养结肠细胞、养有益菌（prebiotic）。多个兽医科普一致推荐（Biology Insights；CatSphere；ScienceInsights）。	**≤1 茶匙/天（≈5g），分 2 餐**；多多从 ¼–½ 茶匙/餐起。过量反致胀/泻（见"过量红线"）。
白米饭 / 米汤（少量）	低敏、易消化碳水，供能且略"收敛"，是经典 bland diet 组分。猫非必需碳水，**仅恢复期少量**作粘合/能量。	占小比例（约餐量 10%）；非主食。
熟鸡蛋黄（蒸熟，适量）	含卵磷脂、维生素与易吸收营养；**熟**制避免生蛋清中抗生物素蛋白(avidin)干扰。不过量、确认不过敏。	隔天半个蛋黄拌入；观察便便。
凉白开 / 无盐无葱蒜肉汤	腹泻丢水丢电解质；猫渴感弱、吃干粮更易缺水。增加液体摄入防脱水、软化通过（VCA：腹泻猫必须保证饮水）。	多置水碗 + 流动水；肉汤每日少量。
益生菌（含特定菌株，见 B5）	菌株特异性地恢复菌群、竞争病原、产 SCFAs、提升肠道 IgA。	按说明拌入；水温≤40℃以免杀活菌。
洋车前子壳粉（可溶性纤维，极少量）	高纯度可溶性纤维，大肠性腹泻时形成凝胶固化粪便；需充分泡发。**用量需兽医指导**，过量反致胀/泻。	极少量（牙签尖）泡水后拌入；非必需。

南瓜为什么能帮猫咪"固便"？ 南瓜富含可溶性纤维，蒸熟压成泥喂下后，纤维在肠道里吸水膨胀、形成柔软凝胶，把松散的水分"兜住"，帮助便便从糊状/水样慢慢回到成形状态。它**不是止泻药**，不会抑制肠蠕动，只是让水分和成形度更正常，相当于天然的"固便帮手"。营养学上把这类能让稀便"拢"成形的物质称为**固便/收敛剂**，日常中文我们直接说**"南瓜帮助固便"**或**"南瓜的收敛成型作用"**就好，后文统一用这两种中文说法。

茶匙到底是多少（按克数）？ 1 茶匙(teaspoon, tsp)≈5 mL；南瓜泥/肉泥密度接近 1 g/mL，故 **1 茶匙 ≈ 5 克。**常用换算：

量	近似体积	近似重量（南瓜/肉泥）
¼ 茶匙	1.25 mL	≈ 1.25 g
½ 茶匙	2.5 mL	≈ 2.5 g
1 茶匙(tsp)	5 mL	≈ 5 g
1 汤匙(tbsp)	15 mL	≈ 15 g

注：干料（如洋车前子壳粉）更轻，同体积克数更小；湿泥按上表估即可。

过量红线（量化清楚）：

项目	3kg 幼猫合理量	过量信号 / 红线
干粮 / 日	60–84 g（分 3–4 餐）	持续 >90 g/日 或 单餐吃撑 → 软便/吐
单餐（4 餐制）	15–21 g	单餐 >30 g 且便便变软 → 立即减
南瓜 / 日	≤ 1 茶匙(≈5 g)，分 2 餐	**>2 茶匙(≈10 g)/日 → 胀气、反致泻**
鸡胸肉湿重（作主食）	每日 120–200 g 湿重，分 4 餐	纯肉无碳水长期→营养不全；需搭配南瓜/少量碳水
零食 / 猫条	恢复期尽量 0	任何猫条都可能诱发（见 B7.5）

判断"过量"的黄金标准：**便便从 2–3 级掉到 4 级及以上、或腹胀/呕吐**＝这餐/这天多了，下次减 10–15%。

居家"温和餐"参考配方（腹泻活动期 / 过渡期） + 一锅出做法

组成：蒸熟鸡胸肉（去脂）70% + 熟南瓜泥 20% + 软米饭/米汤 10% + 少许无盐肉汤调湿度。

多多的量（按 3kg 算）：每日总量约 **150–200 g 湿重**，分 **4 餐**，每餐约 **40–50 g。**若便便偏软，先给下限（每餐 35g）；稳定后再提到中上限。

一锅出做法（鸡胸肉 + 贝贝南瓜同锅蒸）：鸡胸肉 1 块（约 100g，去皮去脂） + 贝贝南瓜 100g（去皮去籽切小块）放入蒸锅/盘，**水开后蒸 12–15 分钟**至肉熟透、南瓜软烂；取出鸡肉撕碎/切小丁，南瓜压成泥，按 7:3 混合后拌少许蒸出的原汤调湿度即可。**人猫可同锅：人那份盛出后自行加酱油/椒盐；猫那份保持原味无盐无葱蒜。**

理论：高消化动物蛋白（少渗漏溶质）+可溶性纤维（吸水固化）+低脂肪（减轻负担）+少量易消化碳水（能量）+少食多餐（降低每餐渗透压负荷）。便便回到 2–3 级稳定 3–5 天后，再按 B4 缓慢过渡到常态饮食。

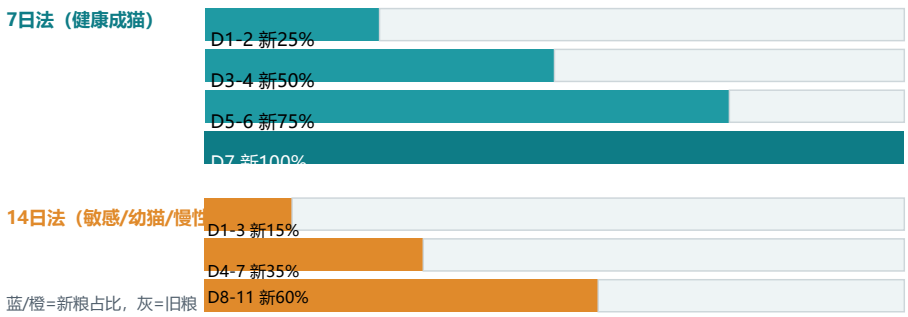
> **绝对避免：**高盐/调味人食、生肉生鱼、虾壳虾头、牛奶（猫乳糖不耐）、高脂、葱蒜（溶血）、葡萄/巧克力、突然换粮、多种零食轮换、人用止泻药（多数对猫有毒，须兽医处方）。

B3 水分管理

- **为什么重要**：猫祖先来自干旱环境，渴感弱；吃干粮猫普遍慢性缺水。腹泻时水分从肠道大量丢失，**脱水是幼猫最危险的并发症。**
- **怎么做**：家中≥2 个水碗分散放置；用流动饮水机提升兴趣；湿粮/肉汤提升摄入；腹泻期可少量多次补电解质（兽用口服补液盐，遵医嘱）。
- **自测脱水**：提颈后皮肤，松手后 1 秒内回弹为正常；回弹慢、牙龈干、眼窝凹 = 脱水，就医。

B4 过渡换粮法（7 日 / 14 日） +「只有新粮、老粮买不到」情形

猫肠道菌群对旧粮配方有"记忆"，骤换→菌群来不及适配→渗透压失衡/发酵→软便。权威营养学会与多篇兽医科普均推荐**渐进换粮**；肠胃敏感/幼猫/慢性肠病者拉长到 **10–14 天**（台湾宠物营养保健食品学会；东北网引《2026中国宠物行业白皮书》；氧宠博士）。



便便是推进依据，不是日历：出现软便→停在当前比例稳住 2–3 天；加重→退回上一档甚至回旧粮；一切正常才进下一档。敏感猫实际常需 10–14 天，慢不是失败。

⚠️ 只有新粮、老粮买不到（多多当前情形）

多多目前"老粮只剩一点、买不到了、只有新粮（京东京造）"，无法做经典的旧:新混合过渡。处理原则：

1. **榨干最后一点老粮做缓冲**：若还剩少许老粮，把它与**大量新粮**按 老 20%:新 80% 先混 2–3 天，再 0:100，相当于用极少老粮"稀释"新粮冲击（比直接全换温和）。
2. **若老粮彻底没有 → 必须全换新粮时，用"温和餐桥接法"降低刺激**：先以 B2 的鸡胸肉+南瓜温和餐为主食 2–3 天，让肠道休息；随后把新粮**碾碎/泡软**少量拌入温和餐，从 15–25% 新粮开始，按 14 日法的节奏（但用"新粮占温和餐比例"来推进）缓慢加到全量。
3. **全程少食多餐 + 南瓜帮助固便（¼–½ 茶匙/餐）**，每天记便便分级。
4. **红线**：全换新粮后若便便 ≥5 级持续 >2 天、或呕吐/沉郁 → 立即就医，并考虑改用兽医处方胃肠粮或低敏粮（见 B7.5 / C2）。

核心：不能渐混时，用"温和餐桥接 + 泡软新粮 + 慢比例"替代"旧:新混合"，目标同样是给肠道菌群适应期，而不是硬切。

B5 益生菌 / 益生元

事实层（有研究支持）

猫咪腹泻相关益生菌证据最强的是

特定菌株

：*Enterococcus faecium* SF68。随机对照试验显示，服 SF68 的猫腹泻评分显著低于安慰剂组（P=0.0058，PubMed 29291771, 2017）；该菌株在收容所猫、慢性非特异性腹泻猫、幼猫中均被证实可改善粪便质量/预防腹泻（Purina FortiFlora 资料；AAFP 会议综述）。*Saccharomyces boulardii*（布拉氏酵母）在人或犬猫腹泻中亦有应用（氧宠博士提及）。

推断层

多多属"菌群偏弱 + 急性炎症后未完全恢复"，补充

有研究背书、标明菌株与活菌数

的益生菌，理论上有助于菌群重建与肠黏膜修复，但属于辅助而非治疗根本病因。

建议层

选购时认"菌株名 + 活菌数 CFU + 有临床研究/兽医推荐"，不迷信"含益生菌"泛称；AAFP 综述提醒部分产品

实际活菌不达标

，质量参差。拌入食物、水温≤40℃。

B6 常用药物机理与红线

类别	机理	居家红线
蒙脱石类（吸附剂）	物理吸附毒素/水分、保护黏膜	需兽医指导用量；与益生菌/药隔开 2h 服，否则互相吸附失效
益生菌（见 B5）	恢复菌群、竞争病原	选对菌株；非万能，无效要查因
抗生素（如甲硝唑）	杀厌氧病原/抗炎（IBD）	**必须兽医处方**；滥用伤菌群；幼猫剂量敏感
驱虫药	清除寄生虫	即便粪检阴性，慢性软便兽医常仍建议"经验性驱虫"；按体重给药
人用止泻药	—	**多数对猫有毒（如洛哌丁胺可致中枢抑制），严禁自用**

红线总结：任何人用止泻/抗菌药都不要给猫自行使用；药物仅限兽医处方。居家能做的=饮食管理 + 补水 + 记录 + 益生菌辅助。

B7 居家护理与记录表

记录是给兽医最有价值的素材。建议连续记 2 周：

日期	便便分级(1-7)	次数	颜色/血/黏液	当日饮食	精神/食欲	备注
—						
—						
—						

同时每周称一次体重（幼猫用厨房秤），毛色/体重是比便便更客观的"长期健康指标"。多多"发黄"建议同步观察体重与营养摄入。

B7.5 别的猫吃罐头/猫条没事，多多一吃就拉？是肠胃弱，还是量大？

多多 4 个多月吃罐头/全价湿粮就腹泻，当时以为恢复、后来才察觉是猫条或罐头导致的——这类"别人吃没事、他一吃就事"很典型，原因通常是**多重叠加**，而非单一：

可能原因	机制	对应多多的情况
先天/幼期肠道耐受弱（"玻璃胃"）	菌群定植弱、消化酶与黏膜屏障未稳；幼期"很饿→暴食→软便"进一步损伤耐受力	高度符合：他从小吃多就拉、减量才正常
食物不耐受（非过敏）	剂量依赖：某种成分（胶质增稠剂、动物消化物、鱼/禽脂肪、特定蛋白）超过他肠道处理能力即泻，**与"别的猫"无关**	罐头/猫条常含卡拉胶、瓜尔胶、诱食剂、较高脂肪
单次吃得偏多	猫条/罐头适口性高→他容易一次吃超量→渗透性腹泻	需结合"吃多就拉"的体质判断
添加剂/高脂刺激	零食类脂肪与风味剂偏高，敏感肠易激	猫条尤甚
菌群未建立	幼猫菌群本就脆弱，湿粮/零食改变更快	符合年龄

结论：更可能是"**敏感肠 + 不耐受（剂量/成分依赖）+ 可能吃多**"的组合，**不一定是"过敏"**。过敏通常伴随瘙痒/呕吐且微量即发；他主要是腹泻且"吃多/特定零食"诱发，更偏不耐受。处理：**恢复期严格停猫条与罐头**，待肠道稳定后若想尝试湿粮，用"单一蛋白、无胶质增稠剂"的处方/低敏湿粮，从极少量（指甲盖大小）开始、3–5 天观察，逐步加量——这本身就是 B1 树里的"食物排查试验"。

B8 人猫可共享的恢复餐（5 个一锅出菜谱）

以下食材对**猫恢复**与**人营养**都友好（瘦肉蛋白 + 可溶性纤维 + 补水）。**铁律：猫那份必须原味——无盐、无葱蒜、无油、无调味；人那份盛出后再自行加盐/酱油/香料。**葱蒜类对猫溶血有毒，务必分碗前分开。

给猫的量通用原则（默认按 3kg 幼猫）：以下菜谱猫每日总量约 **150–200 g 湿重**，分 **4 餐**，每餐 **40–50 g**。若便便偏软先从每餐 35 g 起；若吃干粮，则干粮按 D2 公式，这些菜只作为辅食/过渡餐。

① 鸡胸肉 + 贝贝南瓜 一锅蒸（最基础）

食材：鸡胸肉 1 块（约 100g）、贝贝南瓜 100g（去皮去籽切块）。

做法：同盘水开后蒸 12–15 分钟，肉熟南瓜烂；肉撕丁、南瓜压泥，按 7:3 混合，拌少许原汤。

多多的量：每日 150–200g（分 4 餐，每餐 40–50g）。

人猫分餐：猫吃原味；人蘸酱油/椒盐。

② 鸡胸肉南瓜小米粥（肠胃温和）

食材：鸡胸肉 80g（剁碎）、贝贝南瓜 80g（泥）、小米 30g。

做法：小米先煮 10 分钟，加鸡肉碎与南瓜泥再煮 8 分钟成粥。

多多的量：每日 160–220g 粥（分 4 餐，每餐 40–55g）；小米只是辅助，猫那碗以肉南瓜为主。

人猫分餐：人可加盐/蛋/青菜；猫那份无盐。

③ 全熟水煮蛋 + 南瓜泥（高蛋白）

食材：鸡蛋 1–2 个、贝贝南瓜 80g。

做法：鸡蛋冷水煮 10 分钟全熟；南瓜蒸/煮烂压泥。

多多的量：蛋黄 ½ 个 / 天 + 南瓜泥 5g（约 1 茶匙），分 2 餐拌入主食；蛋白少量给，观察耐受。

人猫分餐：人吃全蛋；猫只吃蛋黄 + 少量蛋白。

④ 鸡胸肉胡萝卜冬瓜清汤（补水优先）

食材：鸡胸肉 100g、胡萝卜 30g、冬瓜 50g（均切块）。

做法：清水煮 15 分钟成清汤，肉菜捞出。

多多的量：肉＋菜每日 100–150g（分 3–4 餐），另喝 30–50mL 无盐清汤。

人猫分餐：猫那份先捞出，再加盐/葱给人。

⑤ 鸡胸肉＋南瓜＋白菜 一锅炖（饱腹版）

食材：鸡胸肉 100g、贝贝南瓜 100g、白菜叶 50g。

做法：鸡肉先炖 8 分钟，下南瓜再 5 分钟，最后下白菜 2 分钟。

多多的量：每日 150–200g（分 4 餐，每餐 40–50g），白菜给少量即可。

人猫分餐：人吃整锅加盐/生抽；猫吃原味。

以上 5 款均可"人猫同锅、分碗调味"。恢复关键食材就三样：**鸡胸肉（优质蛋白）、贝贝南瓜（可溶性纤维帮助固便）、足量饮水。**零食/猫条/罐头在恢复期内一律不共享。

B9 可冷冻预制菜谱 5 个（一次备餐，随吃随热）

适合周末批量做、分装冷冻，工作日取出蒸/微波加热即可喂猫（加热后放凉至温热，≤40℃，避免烫伤）。所有预制菜**猫的那份仍须无盐无葱蒜。**

冷冻与复热原则：用食品级硅胶冰格或密封小袋分装成"一餐一份"；冷冻 ≤2 周为宜；复热蒸 8–10 分钟或微波 20–30 秒，中间搅拌防烫不均。复热后当天吃完，不复冻。

① 鸡肉南瓜泥冰格（最通用）

食材：鸡胸肉 400g、贝贝南瓜 200g、原汤 50mL。

做法：鸡肉蒸熟撕碎/打碎，南瓜蒸熟压泥，混合成湿润泥状；填入冰格，每格约 40g；冷冻。

多多的量：每餐取 1 格（约 40g），每日 4 格；可单独吃，也可拌入泡软的干粮。

② 鸡肉胡萝卜小丸子

食材：鸡胸肉 300g、胡萝卜 80g（煮熟打泥）、少量南瓜泥 50g。

做法：所有材料用料理机打成肉泥，搓成 20g/个的小丸子；蒸熟后放凉冷冻。

多多的量：每餐 2 个（约 40g），每日 4 餐共 8 个。复热蒸 8 分钟。

③ 三文鱼南瓜泥（仅限确认对鱼耐受）

食材：三文鱼 200g、南瓜 150g。

做法：三文鱼蒸熟去刺捣泥，南瓜压泥，混合后分装。

注意：多多对虾头敏感，鱼类/海鲜需谨慎。建议肠道稳定 2 周后，先试 5g 观察 3 天；无反应再增量。

多多的量：确认耐受后每餐 35–40g，每日 4 餐。不耐受则弃用。

④ 鸡肉冬瓜补水块

食材：鸡胸肉 300g、冬瓜 200g（切块）、清水 100mL。

做法：鸡肉与冬瓜加水煮 15 分钟，连汤带料打成泥，分装冷冻。

多多的量：每餐取 1 份约 50g（含汤），每日 4 份。特别适合腹泻补水期。

⑤ 蛋黄鸡肉能量块

食材：鸡胸肉 300g、熟蛋黄 3 个、南瓜泥 100g。

做法：鸡肉蒸熟打碎，蛋黄压碎，与南瓜泥拌匀，压成薄饼后切 3cm 方块；冷冻。

多多的量：每餐 1 块（约 35–40g），每日 4 块。蛋黄每周总量不超过 2–3 个，本配方按 1 周量做。

B10 京东京造 0谷物6肉8果蔬 猫粮评估

以下基于商品详情页公开成分与营养指标，结合中国猫粮国标 GB/T 31217-2014 做客观判断，**不构成购买推荐。**

指标	京东京造 0谷物6肉8果蔬	国标要求（幼猫/成猫）	是否达标
粗蛋白质	≥38%（部分规格 42%）	幼猫≥28%，成猫≥25%	✅ 达标且偏高
粗脂肪	≥16%	≥9%	✅ 达标
牛磺酸	≥0.2%	干粮≥0.1%	✅ 达标
粗纤维	未完整标注	—	⚠️ 未知
钙 / 总磷	钙≥1.0%；总磷商品页标"≥16%"（明显为数据录入错误，真实值应在 0.8–1.2% 区间）	钙≥1.0%，磷≥0.8%，钙磷比 1:1–2:1	⚠️ 公开数据有矛盾，无法核验钙磷比
谷物	0 谷物	无强制要求	✅ 对谷物敏感猫友好
动物蛋白来源	鲜鸡肉、鸭肉粉、牛肉粉、羊肉粉、鳗鱼/鲤鱼粉、磷虾粉（共 6 种肉）	—	⚠️ 肉源复杂
果蔬/其他	西蓝花、苹果、南瓜粉、菠菜、胡萝卜、蔓越莓粉、蓝莓、番茄（8 种）＋200亿 CFU/kg 益生菌	—	⚠️ 成分繁多，敏感猫风险↑

事实层

从粗蛋白、粗脂肪、牛磺酸三项核心营养看，该粮达到并超过国标，属于"营养指标合格"的干粮。

推断层（针对多多个案）

- **0 谷物是优点**

  ：减少麸质等植物抗原对敏感肠的刺激。

- **6 种肉 + 8 种果蔬是双刃剑**

  ：对普通猫意味着"营养多样"；对多多这种 already 敏感、曾因虾头/湿粮/零食腹泻的猫，**原料越复杂，潜在不耐受/过敏触发点越多**。

- **含鱼贝类（鳗鱼/鲳鱼/磷虾）**

  ：多多此前对虾头反应强烈，虾属于甲壳类，磷虾也是甲壳类；鱼类亦是常见食物不耐受源。该配方对他存在**理论风险**。

- **公开钙磷数据有错误**

  ：商品页"总磷≥16%"不可能，真实磷含量未知，无法判断钙磷比是否在安全范围。长期钙磷失衡影响骨骼与肾脏。

- **益生菌宣传**

  ：200亿 CFU/kg 是添加量，不等于到达肠道时的活菌数；高温膨化会杀死部分菌株，实际效果看具体工艺与包被。

建议层

1. **可以短期作为"只有新粮"的过渡选择**

   ：毕竟营养指标合格、0 谷物，比直接断粮或长期吃单一鸡胸肉更符合猫全面营养需求。

2. **但不建议作为多多的"终身唯一粮"**

   ：若按 C3 14 天计划喂后，便便仍反复 ≥4 级，说明他对其中某个/某些原料不耐受，应换
   单一肉源低敏粮

   或
   兽医胃肠道处方粮

   。

3. **更优的长期方向**

   ：稳定后选择肉源简单（如单一鸡肉/鸭肉）、0 谷物、无鱼贝、有明确菌株益生菌的低敏粮，或在兽医指导下做食物排查试验。

4. **喂法**

   ：按 B4"只有新粮"桥接法过渡，不要直接全换；日粮总量参考 D2 按体重计算，从下限开始。

Part C · 多多专属方案

C1 个案时间线复盘

时间	事件	解读
幼年期	很饿→暴食→软便；减量后正常才打疫苗	先天/喂养不规律致肠道耐受力偏弱，"吃多就拉"体质
4 个月+	吃罐头/全价湿粮后出现腹泻；当时以为恢复，后察觉是猫条/罐头导致	早期即对湿粮/零食（胶质、高脂、诱食剂）敏感，佐证"玻璃胃"
约 1 个月前（先）	**打第 2 针疫苗**	疫苗轻微应激，免疫系统波动
其后（后）	**偷吃垃圾桶虾头** → 腹泻开始	虾头诱因叠加：几丁质+组胺+高钠+细菌（见 A2 三联击）
此后 ~1 个月	持续拉稀（间歇性），精神尚可、活蹦乱跳	急性肠炎后未完全平复，或转食物反应性/慢性
近期	就医 + 粪检无异常 + 已驱虫；目前定量三餐但仍拉稀	基本排除寄生虫/传染病；非紧急，但已超慢性阈值(>3周)
当前	老粮只剩一点买不到、只有新粮（京东京造 0谷物6肉8果蔬）；计划继续吃	面临"强制换粮"，见 B4 桥接法；该粮营养指标合格但原料复杂，需观察耐受

C2 研判（事实 / 推断 / 建议 三层）

事实层（已确认）

①公猫约6月；②间歇性腹泻1月余、精神好、粪检阴性、已驱虫；③幼期"吃多就拉"、4月+吃湿粮/猫条腹泻；④打疫苗在先、偷吃虾头在后；⑤定时三餐但仍拉稀；⑥老粮将尽、新粮为京东京造 0谷物6肉8果蔬，计划续吃。

推断层

①寄生虫/传染病基本排除；②核心为"幼期敏感肠＋虾头诱发炎症未愈/食物反应性"；③对湿粮/猫条的不耐受已被多次验证；④京东京造从营养指标看"合格"，但 6 肉 8 果蔬 + 鱼贝类对敏感肠属于**高风险配方**；⑤长期偏低喂食可能营养/水分不足，或关联毛色偏黄。

建议层

①维持定时、改**少食多餐（4餐）**，不盲目再减量；②用 B2 温和餐桥接强制换粮；③南瓜帮助固便＋补水＋有研究背书的益生菌；④停猫条/罐头；⑤记录 2 周；⑥若 >2 周仍反复或出现警示→带新鲜粪便复查（粪PCR/B12/食物试验/低敏粮评估）。

C3 多多的 14 天调整计划（含强制换粮）

阶段	做法	每日总量与分餐	目标
第1–3天	以 B2 鸡胸+南瓜温和餐为主；新粮（京东京造）碾碎泡软，按 15–25% 拌入；若剩老粮则老20:新80 混；每餐拌 ¼–½ 茶匙南瓜；停零食	温和餐湿重 150–200g，分 4 餐，每餐 40–50g；干粮约 15g/日作为拌入	肠道休息＋给菌群适应期，不硬切
第4–7天	温和餐比例降、新粮占比升至 35–50%；南瓜维持 ½ 茶匙/餐；观察便便回 3–4 级	干粮约 30–40g/日；温和餐补足剩余热量	便便成形、稳定
第8–11天	新粮占 60–75%，其余温和餐；仍 4 餐	干粮约 50–65g/日；温和餐约 80–120g/日	逐步衔接新粮而不刺激
第12–14天	评估：稳→维持并缓慢把总量提到合理区间(60–84g/日，分3–4餐)；不稳→就医做食物试验/粪PCR/考虑低敏粮	干粮 60–84g/日或按体重公式；分 3–4 餐	建立长期可维持方案

关于"日总量"：6 月龄、约 3kg 的猫，干粮日需参考约 60–84g。多多目前"定量三餐但还是拉"，正确方向不是再减，而是在**不撑着**的前提下，用易消化高蛋白＋纤维＋少食多餐把总量稳回合理区间，同时观察体重与毛色。若对新粮始终不耐受，应换低敏/处方粮，而不是无限减量。

C4 一页式快速排查卡（可打印）

多多•腹泻快速排查卡

身份：公猫·约6月·狸花猫（疑彩狸/黄狸）·体重请称量后按 D2 公式·商品干粮（京东京造0谷物6肉8果蔬，过渡期观察）·定时多餐

当前状态：间歇性拉稀1月＋、精神好、粪检阴性、已驱虫、无血/无吐/无消瘦；疫苗在先、虾头在后

---

① **每天做：**铲砂看便便分级(目标2–3级)＋记饮食＋称水碗；每周称体重。

② **怎么喂：定时少食多餐（4餐）**，**不要自由采食**（他吃多就拉）；南瓜 ¼–½ 茶匙/餐拌入；老粮尽则按 B4 桥接法换京东京造。

③ **补水量：**多水碗＋流动水＋肉汤，防脱水。

④ **益生菌：**选"标明菌株(如E. faecium SF68)+活菌数"的产品，≤40℃拌入。

⑤ **停一切：**猫条、罐头、人食、虾壳虾头、牛奶。

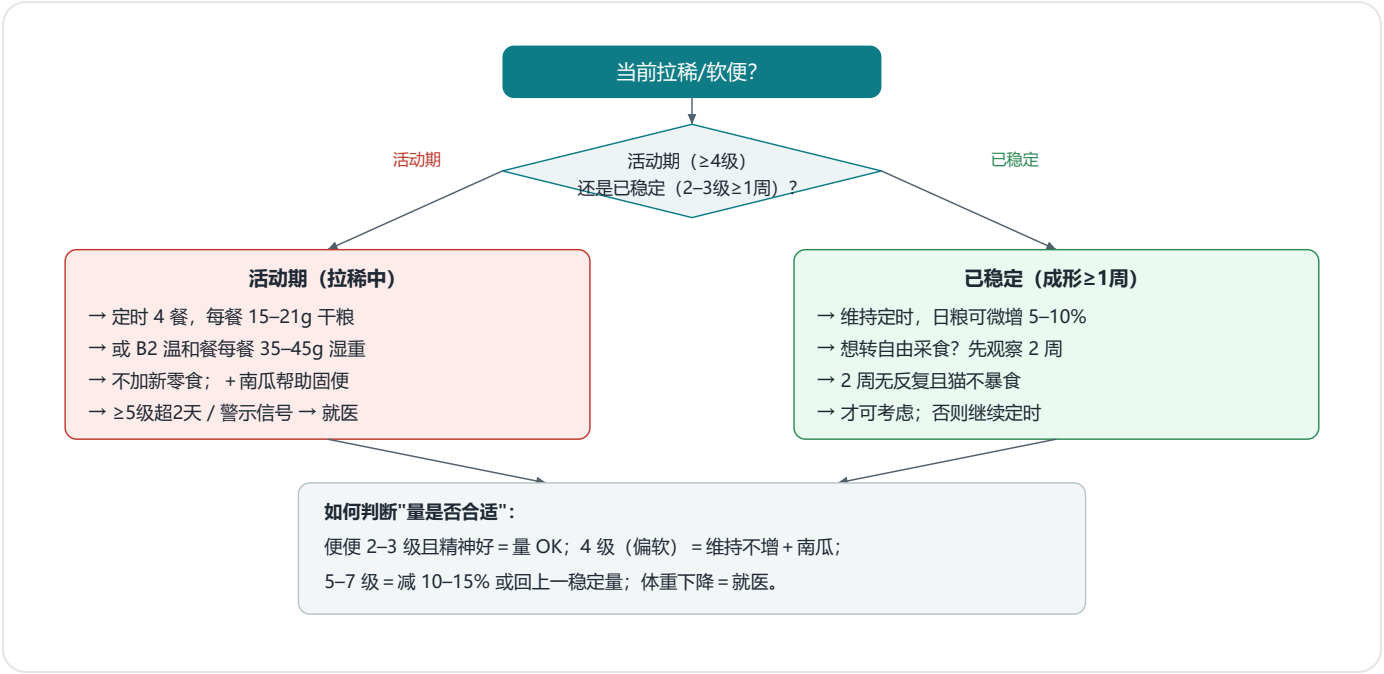
⑥ **立刻就医（任一）：**血便/黑便、呕吐、沉郁、脱水(提皮回弹慢)、消瘦拒食、>2天无改善或反复超3周。

⑦ **复查时点：**按本卡执行 2 周仍反复→带**当天新鲜粪便**就医，查粪PCR/B12叶酸/食物排查试验。

注：本卡为居家管理备忘，不替代兽医诊断。毛色偏黄建议同步关注体重与营养摄入，必要时体检。

C5 怎么喂：定时 vs 自由 ＋ 决策树（多种情况）

结论先行：多多应"定时少食多餐"，不要自由采食。理由：他的病史是"吃多就拉"，自由采食=随时能吃=容易过量→反复软便；定时能把每餐渗透压负荷压低、便于观察"哪餐后拉肚子"反推诱因。



给多少的具体数：6 月龄约 3kg → 干粮日需 **60–84g。**若 4 餐：每餐 **15–21g**；若 3 餐：每餐 **20–28g。**多多现在"定量三餐但还是拉"，可改为 4 餐并把单餐量下调一档（如每餐 17g），同时加南瓜帮助固便观察——**关键看便便反馈，而非死守克数。**

Part D • 养护与行为

D1 如何判断猫咪吃饱了

猫不会用语言说"我饱了"，而且**碗空了≠饿了**——很多猫会把适口性高的食物吃到过量。判断要结合**行为信号 + 身体状态 + 便便反馈。**

信号类型	吃饱了的表现	没吃饱 / 还想吃的表现
进食行为	吃到一半放慢、走开、舔嘴、去理毛或趴下	一直追着你叫、扒碗、吃得太快、吃完立刻找你要
食物残留	定时喂食 20–30 分钟后碗里还剩一点	每次都光盘且还在舔空碗
身体状态	肋骨可摸到但有一层薄脂肪覆盖，腰可见	肋骨突出（偏瘦）或摸不到（肥胖）
便便	成形 2–3 级，每日 1–3 次	吃太多→软便/腹泻；吃太少→量少干硬
精力	有精神、爱玩耍、毛发光亮	无精打采、毛糙、体重下降

> **实操：**定时喂食时，放餐后 20–30 分钟收碗。若猫常剩饭→下顿减 5%；若每次舔得干干净净且体重正常→维持；若舔完还叫且偏瘦→加 5–10%。不要"他叫就给"，很多猫叫是想要关注或馋，不是真饿。

D2 按体重计算每日猫粮量

猫粮包装上给的"建议喂食量"是按理想体重和活动量的大致范围，个体可能差 20–30%。用下面三步法，再按便便调整。

三步计算法

1. 称体重：用厨房秤或抱猫称重法（人抱猫称 - 人单独称）。

2. 算每日热量：

$$\text{日需热量(kcal)} = 70 \times \text{体重(kg)}^{0.75} \times \text{系数}$$

系数参考：6 月龄幼猫 **1.8–2.0**；已绝育成猫 1.2–1.4；肥胖减重 0.8–1.0。

3. 换算克数：

$$\text{日粮(g)} = \text{日需热量} \div \text{干粮热量密度(kcal/g)}$$

普通膨化粮热量密度约 3.6–4.0 kcal/g，具体看包装"代谢能 ME"。

体重	日需热量（系数 1.9）	日粮克数（按 3.8 kcal/g）	4 餐时每餐	3 餐时每餐
2.0 kg	~224 kcal	~59 g	~15 g	~20 g
2.5 kg	~264 kcal	~69 g	~17 g	~23 g
3.0 kg（多多默认估算）	~304 kcal	**~80 g**	**~20 g**	**~27 g**
3.5 kg	~344 kcal	~91 g	~23 g	~30 g

> **多多个案的调整：**上表是"理论上该吃多少"。因为他"吃多就拉"，建议**从同体重范围的下限开始**（3kg 先从每日 60–65g、每餐 15–16g 试起），稳定 3–5 天后再每周加 3–5g。最终目标不一定是表格中位数，而是以**便便 2–3 级、体重稳定或微增**为准。

D3 定时定量 vs 自助采食：优劣对比 + 训猫方法

维度	定时定量	自助采食（碗一直放着）
控制食量	✅ 精确，防暴食和肥胖	❌ 容易过量，尤其适口性好的粮
监测食欲	✅ 哪餐不吃立刻发现	❌ 难判断吃了多少、食欲变化
排查诱因	✅ 便于对应"哪餐后软便"	❌ 无法对应
多猫家庭	✅ 可单独控制每只猫	❌ 强势猫抢食，弱势猫吃不够
对敏感肠	✅ 降低每餐渗透压负荷	❌ 持续进食增加负担
方便程度	⚠️ 需要按时喂、收碗	✅ 省事，适合规律的上班族
猫的心理	⚠️ 初期可能乞食，但可训练	✅ 有安全感，随时可吃

> **结论：多多必须定时定量。**他的核心问题不是"吃不饱"，而是"吃多了消化不了"。自由采食会让他反复软便。等他成年、肠胃稳定、体重正常后，可再评估是否放宽。

训猫适应定时定量的方法

1. **固定时间、固定地点**：每天 4 餐在固定位置放碗，让他形成"到点才有饭"的预期。例如 7:00、12:00、18:00、22:00。
2. **20–30 分钟收碗**：到点不吃也收走，下一顿再给。几次后他会明白"现在不吃就要等"。
3. **不要额外给零食**：乞食时用玩具/互动转移，而不是给吃的。否则他学会"叫就有奖励"。
4. **用益智漏食玩具**：把一餐粮放进漏食球，延长进食时间、增加饱腹感、降低暴食。
5. **渐进调整**：从自由采食改定时，不要一天切换。先白天定时 3–4 餐，夜间短暂收碗，逐步过度到全天定时。
6. **奖励好习惯**：安静等待、自己玩耍时给口头表扬或小零食（总量计入日粮）。

D4 毛色变黄：是营养不够，还是其他原因？

多多"狸花猫但有点发黄"，可能有两类原因：**正常毛色变化** 或 **身体信号**。不要只凭毛色下结论，要结合其他指标。

可能原因	典型表现	自测方法	怎么处理
正常色素/品种因素	毛尖偏黄、皮肤不发黄、精神食欲好、体重稳定	拨开毛看发根和皮肤颜色；在自然光下拍照对比	无需处理，定期观察即可
营养不足（蛋白、必需脂肪酸、锌、铜、酪氨酸不足）	毛发干枯无光泽、易断、体重偏低、精神尚可	称体重；记录饮食；评估蛋白质来源是否单一/不足；拍照 4–6 周后对比	提高优质动物蛋白比例；补充蛋黄（卵磷脂）或鱼油（对海鲜耐受的话）；必要时换营养更全面的粮
护理/清洁问题	毛尖黄、有油垢味、皮肤屑多	用白湿巾擦毛看是否掉色；观察是否过度舔毛	用猫用湿巾擦拭；调整饮食脂肪；必要时兽医皮肤科
环境染色	局部发黄（如蹭到尿、灰尘、烟渍）	洗澡/擦拭后看是否恢复	清洁环境、局部擦拭
黄疸（胆红素高）	**皮肤、牙龈、眼白、耳内侧发黄**；可能伴食欲差、嗜睡、尿黄	在自然光下检查牙龈和眼白；看尿色是否深如浓茶	**立即就医**，查肝功、胆红素、血常规

> **关键区分：**拨开毛看**皮肤**。如果皮肤也黄→黄疸可能，尽快就医；如果只是毛尖黄、皮肤正常→更可能是色素、营养或环境因素。

> **针对多多的建议：**他目前精神好、食欲尚可，重点先排除黄疸（看牙龈/眼白/皮肤）；同时改善饮食质量（B2 高蛋白餐 + 蛋黄），记录体重和毛色 4 周。若体重不增或毛色更黄，就医查肝功和营养指标。

D5 常见猫行为状态判断

猫不会说话，但耳朵、尾巴、瞳孔、身体姿态都在"说话"。学会读这些信号，能早发现不适或压力。

身体部位	放松/舒适	紧张/害怕	兴奋/准备攻击	疼痛/不适
耳朵	向前或自然斜立	向后贴平（飞机耳）	向前竖起、微微转动	不对称、频繁抖动
尾巴	自然下垂或尾尖微弯	夹紧、贴身体	竖起、尾尖弯曲、快速甩动	低垂、不愿被碰
瞳孔	正常大小	放大	放大、紧盯目标	半睁、无神或异常放大
身体	舒展、打滚、慢眨眼	蜷缩、躲藏、弓背	身体压低、臀部扭动	弓背、蜷缩、拒绝移动
叫声	轻柔喵、咕噜	嘶嘶、低吼、嚎叫	短促喵、 chirp	异常安静或频繁哀鸣
行为	主动蹭人、玩耍	躲藏、拒食、乱尿	扑击、抓咬玩具	舔毛减少或过度、食欲变

> **实用口诀：**"耳朵向后要撤退，尾巴狂甩快停手，瞳孔放大别直视，躲藏拒食查身体。" 当猫同时出现 **躲藏 + 拒食 + 精神差**，无论有没有腹泻，都建议尽快就医。

D6 如何训练猫咪

猫可以训练，但方法和狗不同：要用**正向强化**（奖励想要的行为），避免惩罚（惩罚只会让他怕你和躲藏）。

基础原则

- **奖励要及时**：行为发生后 1 秒内给零食，他才懂为什么被奖。
- **饭前训练**：饿的时候动力最强，用正餐粮当奖励也行。

- **短时高频**：每次 2–3 分钟，一天 2–3 次；猫注意力短。
- **一次只教一个动作**，熟练后再加新动作。
- **用响片或固定口令**：如"好" + 零食，建立条件反射。

几个实用训练

目标	步骤	用途
听懂名字/过来	叫名字→零食；逐步拉长距离；只在给奖励时叫名字	唤回、紧急情况召回
坐下	拿零食在他鼻前慢慢向上移→他自然坐下→说"坐"→给零食	餐前礼仪、稳定情绪
进航空箱	把箱子当窝：放零食、毯子；逐步关短时间；出门前才不从"凭空出现"	看病、搬家减少应激
不挠家具	猫抓板放沙发旁；抓板时奖励；抓沙发时平静抱到抓板	保护家具
不咬手	见 D7 详细方案	避免玩耍性攻击/抚摸性攻击

> **核心：**训练不是让猫"听话"，而是建立沟通，让他知道做什么能得到好处。对多多来说，"坐下等开饭"还能防止他因为饿而吃太快、吃太急。

D7 撸猫舒服却转头抱手咬：为什么、如何避免、如何改善

这是典型的**抚摸性攻击/抚摸性过度刺激**（Petting-induced aggression）。猫享受抚摸时，神经兴奋累积到某个阈值，突然觉得"够了"，于是用咬来表达"停止"。这不是猫"坏"，而是**他不会用别的方式说"停"**，而你可能忽略了他 earlier 的警告信号。

为什么会这样

- **静态刺激的阈值**：反复抚摸同一区域会让皮肤神经越来越敏感，超过阈值后从"舒服"变成"不适"。
- **早期信号被忽略**：猫在咬之前通常已经给了很多暗示，只是人没注意到。
- **部位不对**：肚子、尾根、后背末端对某些猫是"禁区"；脸颊、耳根、下巴通常耐受更高。
- **猫的个性差异**：有些猫天生耐受低，只能接受短时间的抚摸。
- **幼猫没学好**：如果幼年期缺少与同类/人的温和互动，容易把咬当成沟通方式。

咬人前的预警信号（出现任一就停手）

信号	表现
耳朵	耳朵开始向后转、飞机耳
尾巴	尾尖快速抽动、尾巴重重拍打地面
皮肤	被摸部位皮肤轻微抽动/起涟漪
头	突然转头看你或舔你的手
身体	肌肉变紧、身体僵硬、停止呼噜
声音	发出低沉喵呜或轻嘶

如何避免被咬

1. **缩短抚摸时间**：每次只摸 5–10 秒，然后停手观察他的反应。如果他还蹭你要继续，再继续；如果他没反应或走开，就结束。
2. **选对部位**：先从脸颊、耳根、下巴开始；避开肚子、尾根和他敏感的后背区域。
3. **看信号**：一旦看到耳朵后转、尾巴甩、皮肤抽动，立刻停手，把手收回。
4. **不要用手当玩具**：从小就不要用手逗他扑咬，否则他会习惯"手=猎物/玩具"。用逗猫棒、玩具老鼠替代。
5. **让猫有掌控感**：让他主动蹭上来求摸，而不是你一把抓过来。他想结束时就让他走。

如何改善（已经会咬怎么办）

1. **不惩罚、不打**：打猫只会让他更紧张，可能升级为真咬或躲你。被咬时平静地把手收走，离开现场，结束互动。
2. **建立"摸=好事"的条件反射**：摸 3–5 秒→给一小块零食→停手。让他把"被摸"和"好吃的"联系起来，同时摸的时间短，不容易触发攻击。
3. **逐步延长耐受**：从他能接受的最短时间开始，每周增加 2–3 秒，配合奖励。不要急于求成。
4. **教他替代行为**：当他开始有咬手倾向时，立刻给玩具（逗猫棒）让他咬；咬玩具=可以，咬手=游戏结束。
5. **降低整体压力**：环境丰富（猫抓板、高处栖息、 hiding places）、规律作息、充足玩耍，都能提高猫的总体耐受阈值。
6. **必要时就医**：如果攻击伴随疼痛反应（被摸到某处就咬）、食欲变化、精神差，要排查皮肤病、关节炎、牙齿问题等。

> **总结：**转头抱手咬 = "我现在不想被摸了"。学会看他的预警信号、缩短抚摸、不用手当玩具，配合奖励和替代行为，绝大多数猫会明显改善。

Part E • 常见问答 FAQ（与主人头脑风暴沉淀的宝库）

围绕"猫咪（多多）腹泻"的高频疑问，按场景拆成 7 类、共 30+ 条问答。每条都是能直接照做的实操答案，并标注证据等级：强 =多中心研究/权威指南；中 =病例系列/专家共识；弱 =个例或经验；禁 =明确有害，切勿使用。

E1 诊断决策类

中 Q1：软便和腹泻怎么区分？一天拉几次算腹泻？

看三件事：**形态、频率、是否带血/黏液**。健康猫便应成形、分节、捡起不散。若粪便持续偏软不成形，或每天排便次数明显多于平时（多数家猫 1–2 次/日），或便中带鲜红血丝/黏液，即属腹泻。偶尔一次软便不必紧张；**液状或半液状持续超过 2 天**应咨询兽医（VCA）。

强 Q2：怎么判断是小肠还是大肠的问题？

核心线索：**小肠性**（量大、次数略增、水样/脂肪样、常伴呕吐体重降、便血少见）→ 偏消化/吸收/全身病；**大肠性**（里急后重、便意频繁、量少、黏液便、便纸/猫砂上新鲜血丝、腹痛努责）→ 偏结肠/直肠炎症（如结肠炎、寄生虫）。这是急诊与检查路径分流的第一依据（Small Animal Internal Medicine Table 11-1）。

强 Q3：便便里有血丝或黏液，要紧吗？

新鲜鲜红血丝 + 黏液 + 努责多为大肠/直肠末端问题（肛裂、结肠炎等），相对常见但需观察；**黑便/柏油样便（消化过的血）**提示上消化道/小肠出血，更需重视。若血丝持续、量多、或伴精神差/呕吐/贫血，立刻就医。少量偶发黏液可先居家观察 24h。

中 Q4：又吐又拉，说明什么？

呕吐+腹泻同现，常见于急性胃肠炎、食物中毒、寄生虫（如蛔虫）、病毒感染（猫瘟/冠状病毒）、突然换粮或误食。风险在于**脱水与电解质紊乱来得更猛**。出现呕吐时先暂停经口喂食 2–4h（不禁水），若持续呕吐或 12h 内无改善，就医。

强 Q5：为什么幼猫（如多多，6月龄）腹泻比成年猫更危险？

幼猫体储小、脱水与低血糖发生快、免疫系统未全、寄生虫/传染病（猫瘟、球虫）更常见且更重。6 月龄仍处于高发窗口。**幼猫腹泻伴精神差/不吃/呕吐，属于急诊**，不可拖延（VCA/猫后苑）。

强 Q6：慢性腹泻（超过 3 周或一月内反复）该从哪查起？

先做"无创三件套"：**多次粪检（漂浮+涂片，间隔数日以抓假阴性）、食物排查（换低敏/单一蛋白 2–4 周）、驱虫覆盖原虫（球虫/贾第虫需特定药）**。仍不明再上血检、fTLI/cobalamin（B12）、超声，必要时肠活检（SpectrumCare）。

E2 居家处理类

中 Q1：刚发现猫咪拉肚子，第一步该做什么？

① **拍照/留样**便便（颜色、形态、有无血/虫）；② 评估精神、食欲、是否呕吐；③ **暂停新零食/新粮**，回到最近稳定饮食；④ 保证饮水；⑤ 记录频率。若精神好、仅软便，可居家观察 24–48h；出现任何警示信号立即就医。

中 Q2：要不要先禁食？禁多久？

仅在**伴随呕吐**时短暂禁食 2–4h（幼猫更短，禁水也仅限呕吐剧烈时短暂）。禁 **不要对单纯腹泻的猫禁食 24–72h**——猫长时间空腹易诱发脂肪肝（尤其胖猫），且肠道需要营养修复。现代指南更推荐"低脂易消化饮食继续喂"而非长期饥饿。

中 Q3：在家能自己喂什么？什么绝对不能喂？

可喂：**白水鸡胸肉、南瓜泥、低脂蛋白主食罐、口服补液**。绝对不能喂：禁 人用止泻抗生素（诺氟沙星/氟哌酸等氟喹诺酮类对猫可造成视网膜损伤）、洛哌丁胺（易中毒）、牛奶、油腻剩饭、洋葱大蒜（溶血）、葡萄（肾毒）、木糖醇（肝毒）。

中 Q4：蒙脱石散（思密达）猫怎么用？

蒙脱石是物理吸附剂，对水样便有收敛作用，相对安全。参考：猫约 **1/4–1/2 小袋（每袋3g）/次，每日 2–3 次**，溶于少量水用针管喂；与其他药/益生菌**间隔 2h** 以免互相吸附。它只对症不治病根，弱 若 2 天无改善应就医。具体用量以体重和兽医指导为准。

中 Q5：益生菌到底有没有用？多久见效？

证据最强的是特定菌株 **Enterococcus faecium SF68**（Purina FortiFlora 所用），RCT 显示可缩短抗生素相关腹泻、改善慢性肠病胃肠评分（P=0.0058）。**2–5 天**可见改善，需连续用 2–4 周。普通"人用酸奶/酵素"菌株不明、定植差，弱 效果存疑，且含糖/乳糖不利腹泻猫。

强 Q6：怎么在家做口服补液？

用**宠物/婴儿口服补液盐（ORS，无糖款）**按说明冲调，或用"少许盐+少许糖+温水"。每次 5–10mL 针管慢推，间隔喂，避免呛。出现 **皮肤回弹慢、牙龈干、精神沉郁**等中重度脱水体征，禁 居家硬灌，立即皮下/静脉补液就医。

E3 喂养营养类

中 Q1：腹泻期间还能吃干粮吗？

干粮低水、高脂、淀粉高，腹泻期不理想。**优先改主食罐/自制低脂高蛋白糊**。若猫只肯吃干粮，可短期少量，但应同时补水、加南瓜泥。恢复期再循序渐进回干粮。

中 Q2：主食罐头 vs 自制，哪个更适合腹泻期？

主食罐（完整营养）> 纯自制（易缺牛磺酸/B12/钙）。自制仅适合短期过渡且必须加复合补充。腹泻期选"肠道敏感"处方罐或低敏单一蛋白罐更稳；自制务必鸡胸肉+南瓜+少量肝+补钙+B 族，不宜长期。

强 Q3：能喝牛奶或羊奶吗？

禁 多数猫成年后乳糖不耐，牛奶会**加重**腹泻。羊奶乳糖略低但仍可能不耐受，且不能替代水。腹泻期一律停奶。如需液体营养，用 ORS 或兽医补液。

中 Q4：南瓜真的能固便吗？怎么喂？

有依据。南瓜富含**可溶性纤维**，蒸熟压泥后在肠道吸水成凝胶，把松散水分"兜住"，相当于天然固便帮手（营养学称"固便/收敛剂"）。喂法：**蒸熟贝贝南瓜压成泥，每餐 1–2 茶匙（约 5–10g）拌入**，连喂 3–5 天观察。忌南瓜派馅（含糖香料）。详见 B2/B7。

中 Q5：只喂白水鸡胸肉够营养吗？

不够，只能短期（2–3 天）过渡。纯鸡胸肉缺牛磺酸、钙、维生素，长期致营养失衡（牛磺酸缺→心肌病）。应尽早回到完整营养主食，或自制时加肝/蛋/钙/B 族。幼猫更不能长期单一蛋白。

中 Q6：需要额外补 B12（钴胺素）、胰酶或牛磺酸吗？

慢性腹泻/肠炎猫常**缺 B12**（回肠吸收受损），补充可改善肠黏膜与食欲（需注射或高剂量口服，遵医嘱）。**胰酶**仅当确诊外分泌不足（EPI）才用。**牛磺酸**是猫必需，主食不足时补。先血检再补，别盲补。

E4 误区辟谣类

禁 Q1："拉肚子就饿三天，让肠胃休息"对吗？

错，且有害。猫长时间禁食易诱发**肝脏脂质沉积（脂肪肝）**，尤其胖猫可数日内危重。禁 对单纯腹泻猫长期饥饿。现代做法是"继续喂低脂易消化食物"，仅在呕吐时短暂禁 2–4h。这是流传最广、危害最大的误区。

禁 Q2：人用诺氟沙星/氟哌酸/泻立停能直接给猫用吗？

禁 绝对不行。氟喹诺酮类（诺氟沙星、恩诺沙星人用剂型）在猫可造成**视网膜变性、永久性失明**；洛哌丁胺猫易中毒（中枢抑制）；人用复方止泻药含猫禁忌成分。止泻必须由兽医开具猫用剂。

弱 Q3：益生菌越多越好、越贵越灵？

否。菌株与剂量比"多"重要。关键看**是否猫用菌株（如 SF68）、CFU 数、是否活菌、有无包埋技术**。人用益生菌菌株未必定植猫肠，且可能含乳糖/添加剂。贵≠对症，按证据选比按价选靠谱。

中 Q4：便便一成形就能立刻换回旧粮吗？

不能急。**稳定成形满 5–7 天**再考虑过渡，且用 7–14 日渐进法换回，避免反弹。若旧粮正是诱因（如某成分不耐受），则不应换回，应继续低敏粮。详见 B4。

禁 Q5：网上"治腹泻神药/偏方/中药丸"可信吗？

禁 多数无批号、无成分、无兽药许可，剂量与安全性未知，可能含猫禁忌（如对乙酰氨基酚、马兜铃酸）。腹泻病因多样，偏方延误诊治风险大。只认有兽药批号或兽医处方的产品。

E5 特殊场景类

中 Q1：搬家/洗澡/去医院后拉肚子（应激性），怎么处理？

应激通过"脑-肠轴"改变蠕动与菌群，可致软便。处理：**减少刺激、提供安全屋、费洛蒙（F3）扩散、保持饮食不变、补益生菌**。多数 1–3 天自限；若超 3 天或带血/沉郁，排查合并病因。

强 Q2：多猫家庭一只腹泻，会传染吗？

看病因。**传染性**：猫瘟、冠状病毒、部分寄生虫（蛔虫/钩虫/球虫经粪口）、沙门菌——需隔离病猫、分开猫砂盆、勤洗手；**非传染**：食物不耐受、应激、特发性肠炎——不传染。保守做法：先隔离+粪检确认，再决定是否合笼。

中 Q3：刚接回家的新猫拉肚子，正常吗？

应激+环境改变常见轻度软便，1–3 天多自限。但新猫也常带球虫/贾第虫等**潜伏寄生虫**，且可能未驱虫。建议：到家先隔离观察、做粪检、按体重驱虫；若伴血/呕吐/不吃，及时就医（别当成"单纯应激"漏诊）。

中 Q4：打疫苗或体内外驱虫后拉肚子，怎么办？

轻微、短暂（1–2 天）软便可能是个体反应，观察即可。若持续/加重/发热，区分是疫苗反应还是恰巧感染。**驱虫后排出寄生虫或短暂胃肠刺激**也常见。症状重或超 2 天就医，不要自行追加药。

弱 Q5：腹泻期间能洗澡吗？

禁 不建议。洗澡增加应激、易受凉，可能加重腹泻或诱发应激性复发。便后只需**局部清洁肛周**（湿巾/温水）即可。待完全恢复 1 周后再洗。

E6 就医与检测类

中 Q1：去医院医生会做哪些检查？大概多少钱？

阶梯式：**基础（粪检+体表+基础血）约数百元**；加腹部超声/生化约千元级；肠活检/内镜更高。具体因城市与医院差异大。带**新鲜便样（2h 内、未沾猫砂）**可省一次采样费。急诊红线（血便+呕吐+沉郁+脱水）直接挂急诊。

强 Q2：便检（粪检）查什么？一定要新鲜便便吗？

查：**寄生虫卵/原虫（漂浮法）、肠道菌群、隐血、消化酶、胰蛋白酶原**等。必须**新鲜（≤2–4h、未污染猫砂）**，否则虫卵变形、原虫死亡致假阴性。球虫/贾第虫一次未必查到，常需**间隔 2–3 天连做 2–3 次**（猫后苑）。

强 Q3：什么情况必须做血检或超声？

出现以下任一项：**精神差/不吃、持续呕吐、脱水、体重下降、血便、发热、腹泻超 1 周、幼猫/老年猫**。血检看炎症/肝肾/电解质/B12；超声看肠壁增厚、淋巴结、异物。这些是排除严重病（肠梗阻、肿瘤、胰腺炎）的关键。

中 Q4：慢性腹泻一直查不出原因怎么办？

走"排查清单"：反复粪检（含 PCR）+ 食物排查（水解蛋白 2–4 周）+ 驱虫覆盖原虫 + 血检（fTLI/cobalamin/叶酸）+ 超声；仍不明考虑**肠活检/内镜**确诊 IBD/淋巴瘤。同时支持疗法（饮食+益生菌+B12）。别因"查不出"就放弃管理。

中 Q5：怎么判断治疗有效、何时复诊？

有效信号：**便形恢复成形、次数回落、精神食欲好转、体重稳定/回升**。急性 3–5 天应见好；慢性以"周"计。若 48–72h 无改善或恶化，复诊。症状消失后**继续巩固 3–5 天**再减药/换回饮食。

E7 产品与测评类

中 Q1：益生菌怎么选（看菌株还是看 CFU）？

两者都看：**菌株**优先选有猫证据的（如 Enterococcus faecium SF68、部分乳酸菌/双歧杆菌猫用株）；**CFU** 看清是"生产时"还是"到期时"活菌数，猫用日剂量常需 10^8–10^9 CFU；看是否**包埋/耐酸**。避开含糖、含乳糖、人用不清楚菌株的产品。

中 Q2：肠道处方粮（敏感肠胃）要长期吃吗？

急性发作期吃 2–4 周；若食物不耐受/慢性肠炎，可在兽医指导下**中长期**作为主食。但处方粮非"治疗神药"，核心是低敏+高消化+特定纤维。**排查出具体过敏原后可换对应低敏粮**，不必一辈子处方粮。

弱 Q3：家庭便检试纸/试剂盒靠谱吗？

弱 家用试纸多为隐血/pH 等单一指标，**不能替代医院镜检+漂浮法**（查虫卵/原虫需专业）。可作初步筛查，但阴性也不能排除寄生虫。确诊仍靠医院粪检（含 PCR）。

弱 Q4：电解质粉/营养膏（如化毛膏、营养膏）要不要常备？

电解质粉（宠物 ORS）**建议常备**，腹泻脱水时救命。营养膏/化毛膏属零食，弱 不能替代主食营养，腹泻期慎喂（部分含麦芽/矿物油不利）。常备清单：ORS、蒙脱石、猫用益生菌、针管、体温计。

弱 Q5：发酵食品（酸奶/开菲尔）能代替益生菌吗？

弱 酸奶含乳糖，多数腹泻猫不耐受，且菌株未必定植猫肠；开菲尔菌群多样但同样乳糖+安全未证。它们**不能替代猫用益生菌**。若想试，选无糖原味且极少量，观察便形，不改善即停。

参考文献与来源

- VCA Animal Hospitals. *Diarrhea in Cats*（定义/病因/严重性/诊断/治疗/预后）. 访问 2026-10-15.
- catmd.ca. *Diarrhea in Cats*（病理生理分类：渗透/分泌/渗出/动力；小肠vs大肠鉴别；病因）. 访问 2026-10-15.
- Expert Cat Care. *Why Does My Cat Have Diarrhea? Investigations & Treatment*（急慢性定义、小肠/大肠表、年龄分层）. 访问 2026-10-15.
- SpectrumCare. *Chronic Diarrhea in Cats*（慢性≥3周或一月内反复；检查路径；警示信号）. 访问 2026-10-15.
- Small Animal Internal Medicine（教科书 PMC7151799）. Table 11-1 小肠 vs 大肠腹泻鉴别. 访问 2026-10-15.
- Torres-Henderson C, et al. *Effect of Enterococcus faecium SF68 on GI Signs and Fecal Microbiome in Cats Administered Amoxicillin-Clavulanate.* Top Companion Anim Med. 2017;32(3):104-108. PMID: 29291771（RCT，P=0.0058）.
- Purina Pro Plan Veterinary Diets. *Feline FortiFlora* 产品资料（SF68 对慢性腹泻/幼猫腹泻证据）.
- AAFP（catvets.com）会议综述. *Probiotics in cats*（证据最强于GI综合征；产品质量参差）. 访问 2026-10-15.
- Biology Insights / CatSphere / ScienceInsights / PetsCare. *Pumpkin for cats diarrhea*（可溶性纤维机理、剂量、忌南瓜派馅）. 访问 2026-10-15.
- 氧宠博士（isdpp.com）. *猫咪"玻璃胃"怎么调理 / 经常软便怎么调理*（定时定量、慢换粮、优质动物蛋白、益生菌）. 访问 2026-10-15.
- 宠搜网（chongso.com）. *猫咪软便原因与调理 / 7天换粮法*. 访问 2026-10-15.
- 台湾宠物营养保健食品学会. *七天渐进去粮法之科学实践与临床指引*（菌群记忆、敏感猫延长10–14天）. 访问 2026-10-15.
- 东北网. *《2026中国宠物行业白皮书》喂养行为调研*（>62%宠主换粮、约四成换粮后软便）. 访问 2026-10-15.
- 猫后苑（catgarden.app, HK）. *猫咪拉肚子原因与就医判断*（7日换粮、寄生虫假阴性、便色判读、慢性>2–3周就医）. 访问 2026-10-15.
- 虾/海鲜风险多篇（ouyi89、ouyi81、dongwangask、baidu健康）. *猫吃虾风险*（虾壳几丁质难消化/梗阻、虾头组胺、高钠、生虾细菌、过敏、零食≤10%热量）. 访问 2026-10-15.
- Radiokop Animal Clinic. *Chronic diarrhoea in dogs and cats*（高消化蛋白+低脂肪 bland diet；益生菌）. 访问 2026-10-15.
- 中华人民共和国国家标准 GB/T 31217-2014《全价宠物食品 猫粮》（粗蛋白、粗脂肪、牛磺酸、钙磷等指标要求）.
- 京东京造商品详情页公开信息（0谷物6肉8果蔬猫粮：粗蛋白≥38%、粗脂肪≥16%、牛磺酸≥0.2%、0谷物、6种肉、8种果蔬、200亿CFU/kg益生菌）. 访问 2026-10-15.

- 国际猫科动物医学协会（AAFP/ISFM）行为指南. *Feline-Friendly Handling Guidelines*（抚摸性攻击、应激信号、训练原则）. 访问 2026-10-15.
- 商品评估说明：文中"京东京造 0谷物6肉8果蔬"仅为结合多多个案的客观分析，非推荐/背书，具体选粮请遵兽医建议。

免责声明：本文为科普与居家管理参考，内容综合自上述公开权威信源并标注，**不能替代执业兽医诊断与治疗**。如症状加重或出现警示信号，请立即就医。

文档版本 v4 ｜ 生成 2026-10-16 ｜ 作者：爱莉（WorkBuddy 执行型协作者） ｜ 同步：ima 中转区 + GitHub Pages + QQ邮箱（jaeyeonn@qq.com）